



PATOLOGÍA QUIRÚRGICA **AVANZADA**

**Hipertensión Portal, Esplenectomía y Tumores
Estromales Gastrointestinales (GIST)**

GUÍA DE ESTUDIO OFICIAL - HIGH YIELD

Ruta de Aprendizaje Clínico

MÓDULO I: SISTEMA PORTAL Y BAZO



Hemodinámica Portal



Hiperesplenismo



Indicaciones Quirúrgicas



Alerta: Síndrome Posesplenectomía

MÓDULO II: TUMORES GIST



Células de Cajal



Topografía



Inmunohistoquímica



Cirugía Molecular

BADBEAR.MED

Dossier Clínico Sonéptico



Hipertensión Portal:
> 10 mmHg

Consecuencias Clínicas



Cirrosis
Hepática



Várices Esofágicas
(Riesgo Hemorrágico)



Esplenomegalia
Masiva

FISIOPATOLOGÍA DEL HIPERESPLENISMO

Hiperfunción esplénica (hemocaterética e inmune - IgG) que deriva en esplenomegalia masiva.



Anemia
(Glóbulos Rojos ↓)



Leucopenia
(Glóbulos Blancos ↓)



Trombocitopenia
(Plaquetas ↓)

PANCITOPENIA



Signos Físicos de Gravedad: Deformidad abdominal masiva y protrusión de la cicatriz umbilical. Enfermedad implacable sin predilección de edad.

HEMATOLÓGICAS

- Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI)
(Causa muy frecuente)

INFECCIOSAS / INFILTRATIVAS

- Mononucleosis, Paludismo
- Fiebre Tifoidea
- Amiloidosis (Riesgo de rotura espontánea)

INDICACIONES ESTRICTAS DE ESPLENECTOMÍA

TUMORALES / ESTRUCTURALES

- Quistes hídricos y pseudoquistes
- Linfomas
- Leucemia crónica

MECÁNICAS

- Rotura traumática
- Rotura espontánea

BADBEAR.MED

ALERTA CRÍTICA: SÍNDROME POSESPLENECTOMÍA

Extirpación del bazo = Pérdida de Properdina = INMUNOSUPRESIÓN SEVERA



Los 3 Asesinos

(Bacterias Capsuladas)

- **1. Neumococo**
- **2. Haemophilus influenzae**
- **3. Streptococo pneumoniae**

Protocolo de Manejo Preoperatorio

- ✓ **Vacunación y antibióticoterapia agresiva.**
- ✓ **Transfusión de plaquetas preparada.**
- ✓ **Manejo del Paciente Engatillado: En PTI con hemorragia subaracnoidea activa por plaquetopenia extrema, la esplenectomía es una emergencia inmediata.**

NEOPLASIAS MESENQUIMALES: G.I.S.T.

Tumores Estromales Gastrointestinales

INCIDENCIA

- Representan el 3% de todas las neoplasias gastrointestinales. Es la neoplasia no epitelial más frecuente del tracto GI.

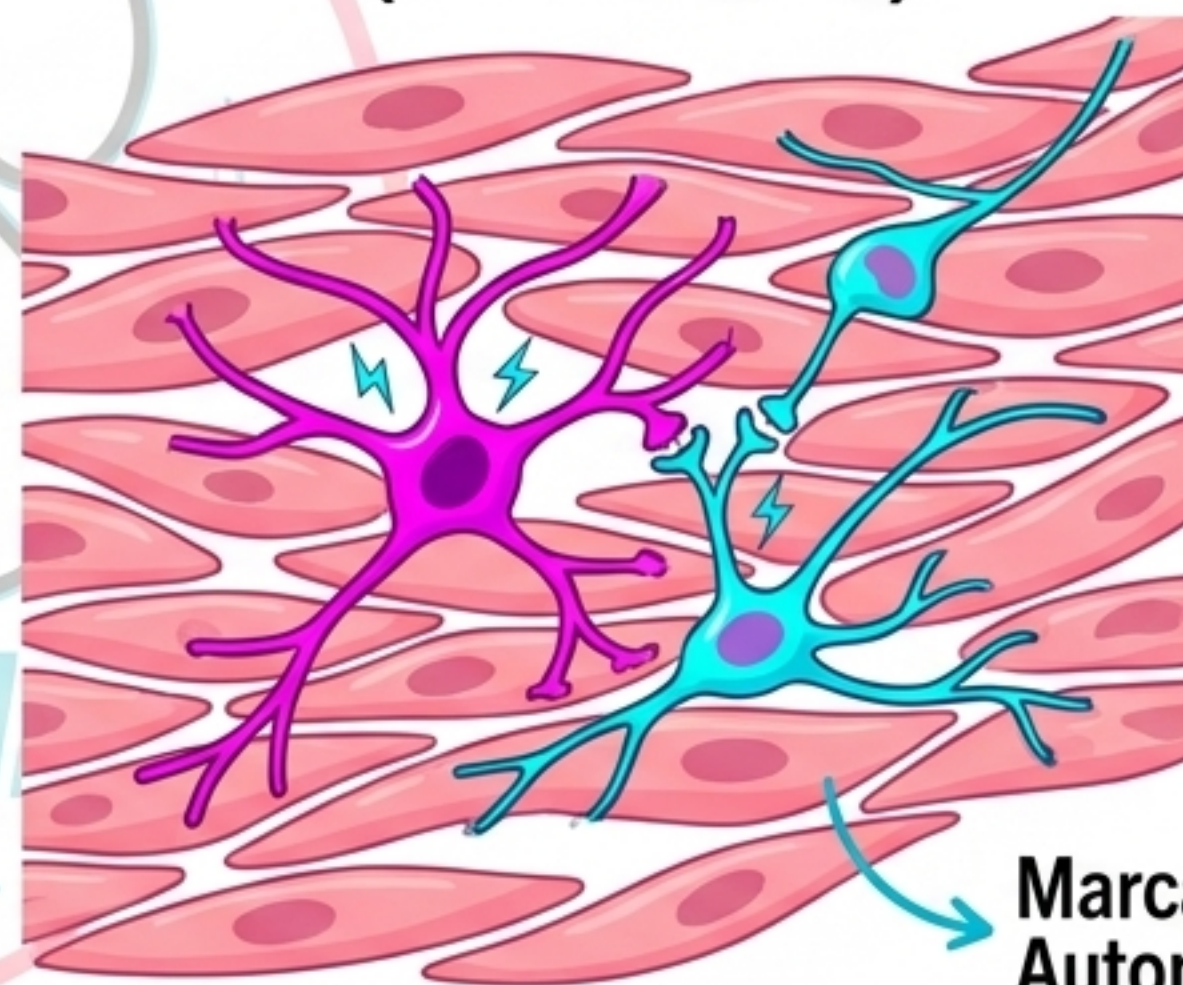
ORIGEN CELULAR

- Derivan exclusivamente de las Células Intersticiales de Cajal.

FUNCIÓN FISIOLÓGICA

- Marcapasos del sistema nervioso autonómico intestinal.

CÉLULAS INTERSTICIALES DE CAJAL
(MARCAPASOS)



Cuadro Clínico

(Dependiente de tamaño y localización)

#4 Esófago

#1 Estómago
(Máxima Frecuencia)

**#2 Yeyuno /
Intestino Delgado**

#3 Colon

(Extra-digestivo raro:
Mesenterio, Epiplón)

**Obstrucción intestinal
media / Intususcepción.**

**Hemorragia digestiva /
Úlcera mucosa.**

**Disfagia
(en masa esofágica).**

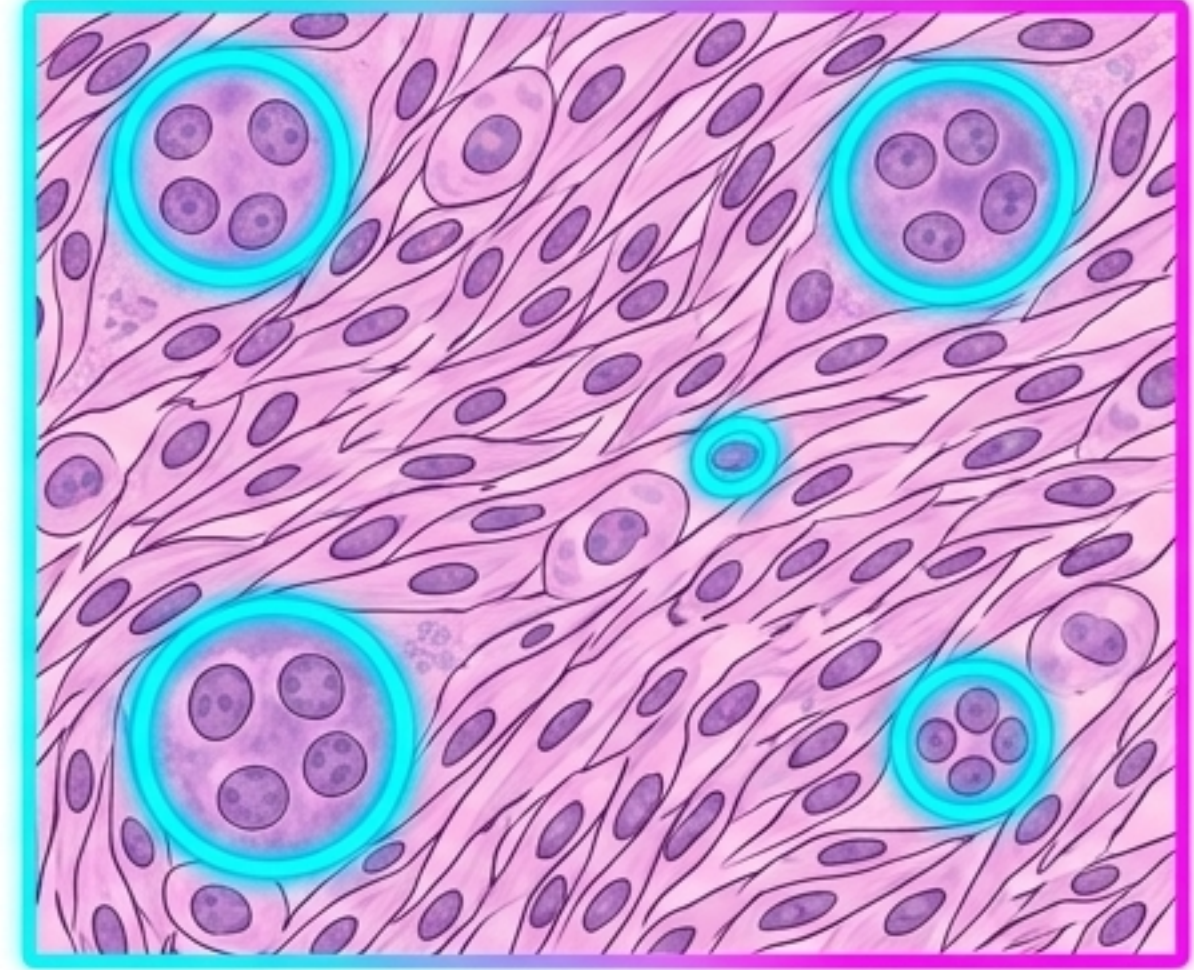
**NOTA: 20% son completamente
asintomáticos en fases iniciales.**

👁️ MACROSCOPÍA



- Tamaño altamente variable: 0.8 cm a 38 cm.
- Contornos bien delimitados y lobulados.
- Aspecto interno arremolinado.
- Frecuente necrosis tumoral y ulceración de la mucosa.
- Crecimiento endoluminal o extraparietal.

🔬 MICROSCOPÍA



- 70% Patrón Fuso-celular (Células fusiformes).
- 30% Patrón Epitelioide o Mixto.
- **HALLAZGO CLAVE:** Presencia de Células Multinucleadas (3 a 4 núcleos por célula).

EL PATRÓN ORO: INMUNOHISTOQUÍMICA

El diagnóstico definitivo es molecular, no puramente visual.



PANEL DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Marcadores Secundarios:** Actina, Proteína S, Desmina.
- **Objetivo Crítico:** Diferenciar el GIST de Leiomiomas, Leiomiosarcomas y Schwannomas.

MATRIZ PREDICTIVA: CRITERIOS DE MALIGNIDAD

FACTORES PRIMARIOS

1.

1. Tamaño del Tumor
(Correlación directa con agresividad)

2. Índice Mitótico

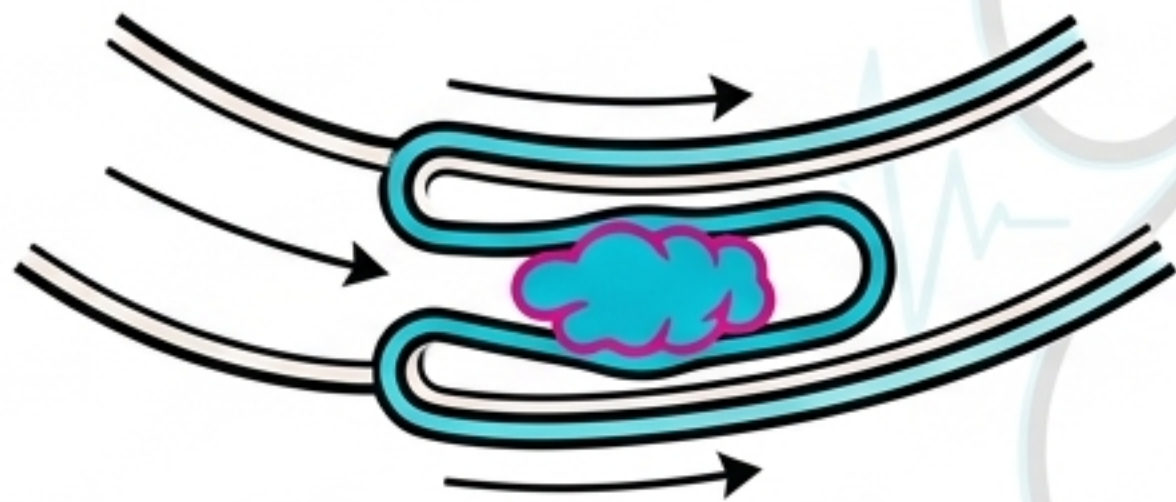
(Intensa actividad de mitosis por campo)



FACTORES SECUNDARIOS

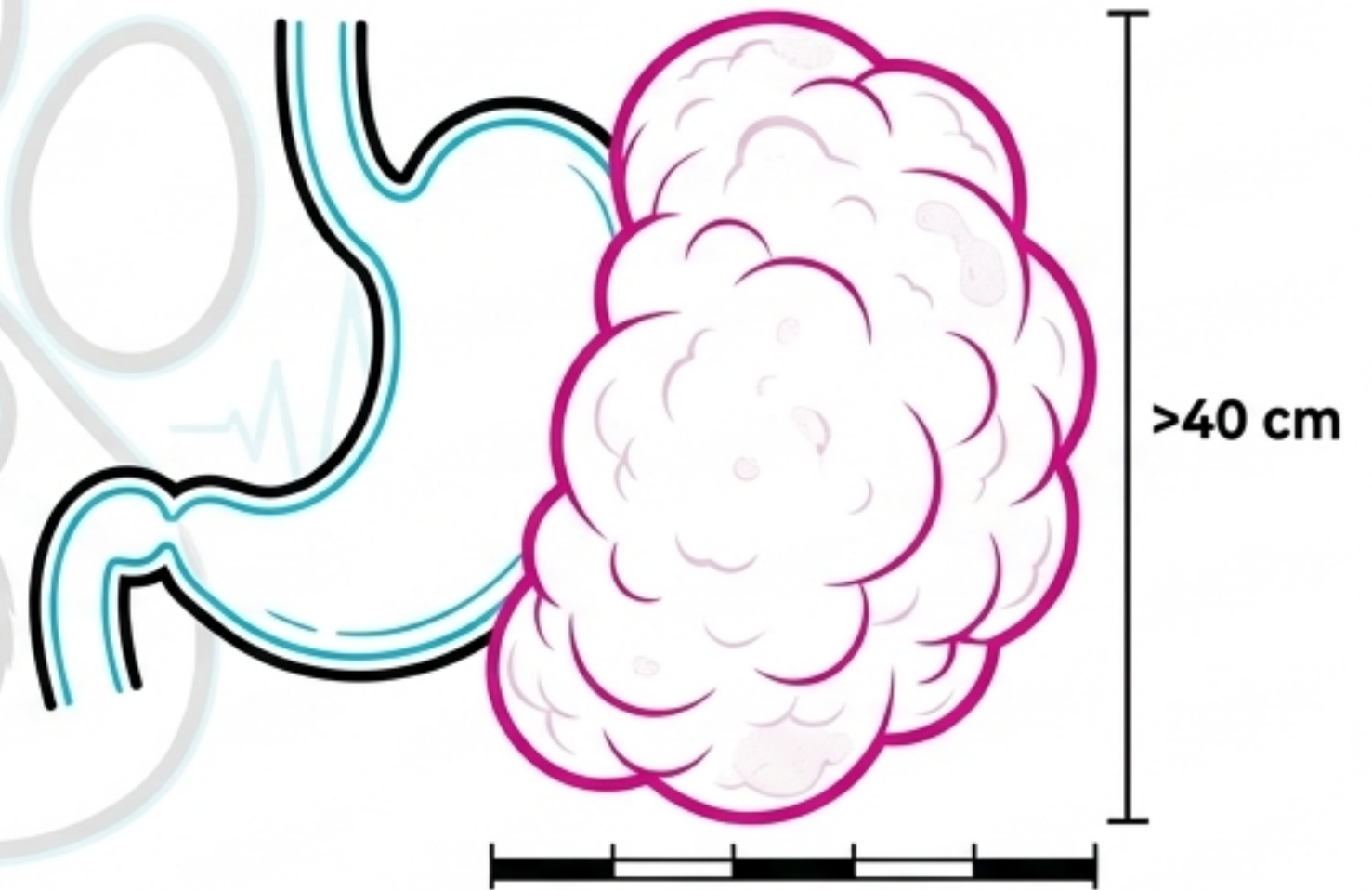
- **Invasión directa de la mucosa.**
- **Intensa celularidad.**
- **Presencia de Necrosis** (Fuerte indicador de comportamiento biológico agresivo).

LA INTUSUSCEPCIÓN



Tumores estromales intraluminales como **causa primaria** de intususcepción en adultos. Genera **suboclusión intestinal severa** y **hemorragia digestiva oculta**.

LA MASA EXTRAPARIETAL GIGANTE



Crecimiento extraparietal silencioso hasta alcanzar **dimensiones extremas** (>38 cm). El tratamiento exige **resección en bloque de la mucosa gástrica adyacente** debido a **infiltración profunda y necrosis tisular**.

PARADIGMA MODERNO: TRATAMIENTO MOLECULAR

ALERTA: La resección quirúrgica aislada presenta una tasa de recurrencia inaceptable (50%).

1. NEOADYUVANCIA (8 Semanas)

- **Fármaco:** Imatinib (Inhibidor bioactivo de Tirosina Quinasa).
- **Objetivo:** Reducir masa tumoral masiva, necrosis focal y mejorar el plano de clivaje anatómico.

2. RESECCIÓN QUIRÚRGICA

Extirpación oncológica del tumor remanente garantizando márgenes quirúrgicos libres.

3. ADYUVANCIA (2 Años)

- Continuación estricta con Imatinib.
- **Objetivo:** Erradicar enfermedad celular microscópica y prevenir diseminación metastásica.

EL FUTURO: CIRUGÍA MOLECULAR E INMUNOLÓGICA



La cirugía contemporánea es prevención genética, conocimiento molecular e innovación inmunológica.

Nuevas Fronteras Quirúrgicas

INMUNIDAD INTESTINAL EN UCI

La nutrición enteral temprana estimula el sistema inmune intestinal (GALT), acelerando dramáticamente la recuperación en estados de sepsis y trauma crítico.

GENÉTICA PROFILÁCTICA

Identificación temprana de marcadores de mutación en grupos familiares de alto riesgo biológico para ejecutar cirugías anatómicas preventivas antes de la malignización.

ÚNETE AL PROYECTO. ESTUDIA INTELIGENTE.

Síguenos para más contenido médico de alto rendimiento.



 /BADBEAR.MED

 @BADBEAR.MED

 @BADBEAR.MED

 BADBEAR_MED

 BADBEAR MED

 BADBEAR.MED

 BADBEAR.MED